

輸尿管重建手術

病人須知 · 修復阻塞或狹窄輸尿管嘅手術

WARWIKI

輸尿管重建手術係用嚟修復阻塞或狹窄嘅輸尿管 — 即係將尿液由腎臟帶到膀胱嗰條管 — 令尿液可以暢流，保護腎臟。手術方式視乎狹窄嘅位置同長度：可以直接接合兩端、用組織移植物 (graft) 修補，或者用一小段腸道代替。

關於呢個程序

輸尿管出現**狹窄**（即疤痕導致收窄），尿液會積聚喺後方，令腎臟承受壓力。手術會針對狹窄情況而定：

- **短段狹窄** — 切除受損部分，將健康兩端縫合，或者將輸尿管重新接駁到膀胱（有時會將膀胱向上拉以便接駁）。
- **較長狹窄** — 用移植組織 (graft) 修補輸尿管，通常取自口腔內壁（另有專門病人須知）。
- **嚴重或長段損傷** — 用自身一小段腸道橋接或替代受損輸尿管。

手術時會放入一條軟身內管（**支架**）撐開修補位置，讓傷口癒合。手術通常以**機械人或腹腔鏡**（微創）方式進行，有時用開放手術。成功率高。

安唔安全？

呢類手術係成熟有效嘅修復方法，會按你嘅解剖結構揀選最合適嘅技術。同所有大手術一樣，有機會出現出血、感染或短暫尿液滲漏（通常靠支架同引流管處理）。狹窄復發並不常見。若使用腸道，腸胃需要幾日才恢復蠕動，尿液或會有少許黏液。

詞彙解釋

輸尿管

將尿液由腎臟帶到膀胱嗰條管。

狹窄 (Stricture)

因疤痕導致收窄，令尿液流動減慢或阻塞。

輸尿管支架

放入體內嘅軟管（「雙J管」），撐開修補位置等待癒合。

移植組織 (Graft)

取自自身嘅組織（通常係口腔內壁），用嚟擴闊輸尿管。

腸道段

取自自身嘅一小段腸道，橋接較長嘅缺損。

重新接駁 (Reimplantation)

將輸尿管重新接連到膀胱。

腎積水 (Hydronephrosis)

因阻塞導致尿液倒流，令腎臟腫脹。

機械人／腹腔鏡

微創手術，只需幾個小切口。

會唔會痛？ 手術係全身麻醉下進行，過程中你唔會有任何感覺。術後切口位置會有酸痛感，體內支架可能引起尿急或輕微腰側不適。若使用腸道，腸胃需要幾日「醒返」。大多數病人住院 1-3 晚，手術時間視乎修復方式而定。

點樣準備（手術前）

- 手術需要**全身麻醉** — 遵從所有術前指示（禁食，以及哪些藥物需要暫停，包括薄血藥）。
- 術前需要**驗尿**，確保無感染 — 若有感染須先治療。
- **唔好吸煙** — 吸煙會減慢癒合。若可能需要腸道段，你或需要腸道準備；若可能用口腔黏膜移植，要注意口腔護理。
- 準備好**支架留置約 4-6 星期**，並安排人送你返屋企。

請**提前**告知醫療團隊，如果你：

- 正在服用**薄血藥**，或者而家有感染
- 曾經做過腹部或盆腔手術，或者曾接受放射治療

手術點樣做

- 1 你係麻醉下入睡，同時靜脈注射抗生素。
- 2 外科醫生切開微創或開放切口，顯露狹窄段輸尿管。
- 3 修復輸尿管 — 將兩端接合、用移植組織修補，或用腸道段橋接 — 並放入支架。
- 4 或會留置引流管，然後縫合切口。

之後

- 通常**住院 1-3 日**後出院。
- **支架留置約 4-6 星期**，之後在診所以快速膀胱鏡取出。
- 支架症狀 — 尿急、輕微腰側不適或尿液帶粉紅色 — 係**正常**嘅。
- 若使用咗腸道段，腸胃恢復期間要清淡飲食。**避免搬重物**數星期。

如果你有以下情況，請即刻聯絡醫療團隊：

- 發燒或畏寒
- 嚴重或加劇嘅腰側或腹部痛
- 大量出血，或者唔能夠小便
- 持續嘔吐，或術後無排氣或排便（若使用腸道段）
- 切口位置愈嚟愈紅、痛或有滲液

要記住嘅三件事

1. 輸尿管重建手術係重開阻塞嘅輸尿管，保護腎臟。修復方式因人而異 — 接合兩端、口腔黏膜移植或腸道段 — 並配合體內支架。
2. 準備工作：遵從禁食及藥物指示、先治療感染、唔好吸煙、預備支架留置約 4-6 星期，並安排接送。
3. 支架取出前會有尿急感，屬正常。若出現發燒、劇痛、大量出血、唔能夠小便或術後腸道無活動，請即刻聯絡醫生。